HELP_Organi_P30 — Groupe F — Lots 247, 248, 217 à 226 — 15 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 30 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

F-006 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › point 11.B › mavacamten ; Partie 3 › DX.7 › point 11.C

Contexte : Le cours cite Camzyos® 5 mg/j, paliers 2,5–15 mg, seuils de FEVG 55 %/50 %, métaboliseurs lents CYP2C19 ; adaptations rénale/hépatique « donnée non trouvée ».

Question : Quelles adaptations rénale et hépatique, quelles interactions CYP2C19/CYP3A4 et quel calendrier de surveillance échocardiographique l'IP suisse de Camzyos® prévoit-elle, et la Suisse impose-t-elle un génotypage CYP2C19 avant traitement ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-008 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › point 11.B › modulateurs de CFTR ; Partie 3 › DX.6 mucoviscidose › point 11.B (fenêtre élexacaftor/tézacaftor)

Contexte : Le cours cite Trikafta : dès 2 ans avec ≥ 1 allèle F508del, ≥ 12 ans 2 cp 100/50/75 mg le matin + ivacaftor 150 mg le soir ; adaptations « donnée non trouvée ».

Question : Sous quel nom la trithérapie élexacaftor/tézacaftor/ivacaftor est-elle autorisée en Suisse (Trikafta® ou Kaftrio®), avec quelles indications, posologies pédiatriques par poids et adaptations hépatiques (Child-Pugh) et rénales, et quelle surveillance des transaminases l'IP impose-t-elle ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-010 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 11.B › abacavir et clopidogrel

Contexte : Le cours cite Ziagen (HLA-B*57:01 obligatoire) et Plavix® (métaboliseurs lents CYP2C19 : charge 600 mg puis 150 mg/j à envisager, posologie non établie) ; adaptations « donnée non trouvée ».

Question : Que prévoient l'IP suisse de Plavix® et la recommandation européenne la plus récente (ESC) pour le métaboliseur lent du CYP2C19 (alternative prasugrel ou ticagrélor, dose) et quelles adaptations rénale/hépatique s'appliquent à l'abacavir ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-012 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 BRCA › points 9 (gold standard, alternatives grossesse et allergie) et 10

Contexte : Le cours écrit : spécificité du séquençage, test germinal en cours de grossesse, alternative à l'IRM mammaire avec gadolinium en cas d'allergie et conduite chirurgicale devant un variant de signification incertaine : « donnée non trouvée ».

Question : Quelle conduite recommandent les sources suisses ou européennes (ESMO 2023, ENIGMA, SSGO) devant un variant de signification incertaine BRCA, pour un test germinal pendant

la grossesse, et quelle imagerie remplace l'IRM mammaire avec gadolinium en cas d'allergie ou de contre-indication ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-013 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 › points 3, 7 (cancer du sein triple négatif, ovaire, pancréas) et 8 (PALB2, gènes modérés)

Contexte : Le cours cite 8,5 % de variants BRCA1 parmi les triples négatifs [S20] ; prévalence des porteurs dans la population générale, signes d'appel ovariens et risque pancréatique chiffré « donnée non trouvée ». Question pendante HELP LOT_247 V1 n° 11.

Question : Quelle est la prévalence des porteurs BRCA1/2 dans la population générale suisse ou européenne, quels risques cumulés (sein, ovaire, pancréas, prostate) par gène (BRCA1, BRCA2, PALB2) donnent les sources européennes récentes, et quels critères suisses de test (panel) s'appliquent aux gènes de risque modéré ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-015 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › fenêtres transversales 6.1 (informer les apparentés) et 12.1 (dépistage tumoral universel)

Contexte : Le cours écrit : statut juridique de l'immunohistochimie MMR comme analyse génétique au sens de la LAGH, confirmation germinale d'un variant tumoral par analogie avec BRCA, modalités de la lettre aux apparentés : « donnée non trouvée ».

Question : L'immunohistochimie MMR ou l'analyse MSI sur tumeur constitue-t-elle une analyse génétique au sens de la LAGH (art. 3) et exige-t-elle le consentement et le conseil prévus aux art. 5–6 et 21, quelle conduite fixe une source suisse ou européenne pour confirmer en germinal un variant découvert sur la tumeur, et existe-t-il un modèle suisse de lettre d'information aux apparentés ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-017 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 › point 7 (fenêtres trisomies 18 et 13), point 8 (causes non génétiques) et point 11.D

Contexte : Le cours écrit : tableau clinique postnatal des trisomies 18 et 13, pronostic des trisomies et causes non génétiques d'une clarté nucale augmentée : « donnée non trouvée ».

Question : Quels signes cliniques postnatals, quelle survie à 1 an et quelles causes non chromosomiques d'une clarté nucale augmentée (cardiopathie, syndromes géniques, infection) rapportent EUROCAT, la SSGO ou une source européenne récente ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-020 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › point 8 ; Partie 2 › DX.5 › fenêtre 5.1, points 8, 9, 11.B (déférioprone), 11.D

Contexte : Le cours cite EASL 2022 [S37] (IRM ou biopsie si autre génotype), UK Biobank et Melbourne ; condition de jeûne de la saturation de la transferrine, Se/Sp de l'IRM, différentiel de l'hyperferritinémie sans surcharge, posologie hors indication de Ferriprox® et survie : « donnée non trouvée ».

Question : Que recommande la ligne directrice EASL 2022 (texte intégral) sur le jeûne avant la saturation de la transferrine, le différentiel de l'hyperferritinémie dysmétabolique, les cibles de ferritine des saignées, la place des chélateurs et la survie selon le stade de fibrose, et quelle est la fréquence de l'homozygotie C282Y en Suisse ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-021 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › fenêtre bio-

mathématique 10.1 (Hardy-Weinberg) ; Partie 3 › DX.6 › points 3, 8, 9 (panels, risque résiduel), 11.D

Contexte : Le cours dérive la fréquence des porteurs CFTR de l'incidence néonatale suisse (≈ 1/3400, 2011–2021) ; fréquence mesurée des porteurs, sensibilité des panels CFTR en Suisse, prévalence de la consanguinité, survie médiane et thérapie génique : « donnée non trouvée ». Question pendante HELP LOT_247 V1 n° 14.

Question : Quelle fréquence des porteurs CFTR, quelle sensibilité des panels de variants utilisés en Suisse et quelle survie médiane actuelle (registre suisse ou ECFS Patient Registry) publient les sources suisses ou européennes, et existe-t-il des recommandations ECFS sur le test de porteur du conjoint ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-026 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 1 › DX.1 et DX.2 › point 9 (alternatives allergie) ; Partie 3 › DX.7 › point 9 (IRM cardiaque, 2e intention)

Contexte : Le cours écrit : conduite pour le gadolinium en cas de DFGe < 30 mL/min ou d'allergie (IRM mammaire et cardiaque) et imagerie de substitution : « donnée non trouvée ».

Question : Quelle conduite recommandent la Société suisse de radiologie ou l'ESUR (dernière version) pour l'injection de gadolinium chez un patient au DFGe < 30 mL/min et chez un patient allergique aux chélates de gadolinium (agent macrocyclique, prémédication, alternative) ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-028 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Tableau comparatif DX.8 ; Partie 4 › DX.8 › points 3, 7.1, 9 (gold standard, résultats normaux), 11.B, 11.C, 11.D

Contexte : Le cours cite la puce chromosomique en 1re intention (15–20 %) et la PCR/Southern blot [S60, S61] ; fréquence suisse, étapes après une puce normale (exome), prise en charge éducative, calendrier de suivi et âge d'apparition des traits : « donnée non trouvée ».

Question : Quel algorithme étiologique d'un retard de développement ou d'une déficience intellectuelle (puce, FMR1, exome/génome) recommandent une société suisse ou européenne récente, et quel suivi (développement, comportement, femme prémutée : FXPOI, FXTAS) recommandent les sources européennes pour le syndrome de l'X fragile ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus

récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-029 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.9 Huntington › points 3, 5, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11.C

Contexte : Le cours cite EMQN [S56] (≥ 40 CAG diagnostique, 36–39 pénétrance réduite, incidence 3–10/100 000 en Europe de l'Ouest) ; fréquence suisse, âge du début juvénile, spécificité, bilan si < 36 CAG, facteurs modifiant l'âge de début et calendrier de surveillance : « donnée non trouvée ».

Question : Quel protocole de test présymptomatique (nombre d'entretiens, délai de réflexion, accompagnement psychologique) recommandent l'EHDN et une source suisse, quel âge définit la forme juvénile, quelle conduite après un résultat de 27–35 CAG (allèle intermédiaire) et quel suivi après un résultat positif ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-031 — Moyenne — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 3 (offre en génétique, encadré « Calcul ») et badges de fréquence des dix scénarios

Contexte : Le cours cite 47 000 consultations génétiques facturées en 2019 (pool SASIS) et onze conseillers en génétique en 2021–2022 [S7] ; nombre de centres, de spécialistes FMH en génétique médicale et fréquence des scénarios de conseil : « non trouvé ». Questions pendantes HELP LOT_247 V1 n° 1, 2, 13.

Question : Combien de spécialistes FMH en génétique médicale (statistique médicale FMH la plus récente), de centres de génétique médicale et de conseillers en génétique exercent en Suisse, et existe-t-il une répartition suisse des motifs de consultation génétique (oncogénétique, prénatal, cardiogénétique, pédiatrie) ? Citez la source suisse primaire la plus récente (OFS, Obsan, OFSP, registre ou société savante : titre, année des données, URL, date de consultation). Signalez toute rupture de série. À défaut de donnée suisse, donnez la donnée européenne la plus récente en l'étiquetant comme telle.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-032 — Haute — LOT 248 · SSP O7.26

Emplacement : LOT_248_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3–DX.5 › caustiques › point 5 (toxicocinétique) et seuils de gravité

Contexte : Le cours écrit : concentrations et volumes toxiques par agent « donnée non trouvée », sauf gorgée 30–50 mL / grande gorgée 60–90 mL chez l'adulte [S58] ; acide fluorhydrique cité comme exception.

Question : Quels seuils de concentration (soude, acide chlorhydrique et sulfurique, hypochlorite, acide fluorhydrique, pastilles de lave-vaisselle) et quels volumes définissent une ingestion caustique à risque, et quel délai d'endoscopie et quelle conduite (gluconate de calcium pour l'acide fluorhydrique) recommandent Tox Info Suisse et l'ESGE/WSES ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL) qui fixe cette conduite. Comparez sa version la plus récente avec celle du cours et listez les différences. À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-034 — Moyenne — LOT 248 · SSP O7.26

Emplacement : LOT_248_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › fenêtre transversale « intoxication professionnelle au CO » (base légale et déclaration)

Contexte : Le cours cite la LAA art. 9 al. 1 et l'annexe 1 OLAA en relation avec l'art. 14 OLAA [S71]. La réponse Gemini (HELP LOT_248 V1 n° 19) cite la LEp et la LAA sans articles exacts pour les délais de déclaration (question HELP V2 n° 12 restée partielle).

Question : Quels articles exacts fixent l'obligation et le délai d'annonce d'une intoxication professionnelle à l'assureur-accidents (LAA art. 45 ss, OLAA) et la déclaration du botulisme (ordonnance du DFI sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles, annexe et délai) ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P30 — 15 questions : F-006, F-008, F-010, F-012, F-013, F-015, F-017, F-020, F-021, F-026, F-028, F-029, F-031, F-032, F-034